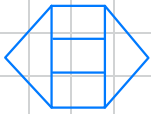


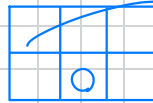
めまい

発症日, 受診時の状況を聴取



→ 回旋

○ : なし
 ⊙ : 怪しい
 → : 左向き
 ← : 右向き



↶

↷

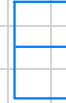
↶

↷

臥位

向地性

背地性



臥位

座位

BPPV

潜時・減衰・疲労現象

方向交代性

自発眼振なし

患側への眼振

発症時, 持続時間

↑
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

を試すことも。

VBI

椎骨Aの低形成・蛇行

数日～翌日まで持続

方向固定性

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

セロワール, サマオン

X=エール病

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

ダイモックス (副作用: しびれ)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

中高年女性

めまいなし

耳閉塞感も

突発性難聴

健側方向に自発眼振

ケリセオールテスト

めまい (有て予後不良)

内服あれば量確認

起立性低血圧

シェロングテスト

Xトロジン (カテコラミン) を使うことも。

前庭神経炎

健側方向に自発眼振

顔面神経麻痺

額の麻痺

十: 末梢

一: 中核

ENoG... 電気刺激を健側と比較, 40%以上であれば7ヵ月以内の治癒が見込める
 6ヵ月以上は治る可能性あり

耳介後部の痛み ー Hunt sx.

アレルギー性鼻炎

下鼻甲介の浮腫

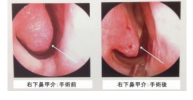
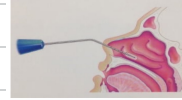
Tx) モンテルカスト:抗ロイコトリエン
アレグラ:抗ヒスタミン
ステロイド点鼻

コプレーターを用いた下鼻甲介ラジオ波凝固治療について

アレルギー性鼻炎などで下鼻甲介という鼻の粘膜が肥大すると、鼻づまりがひどくなります。通常、鼻づまりに対しては内服薬や点鼻薬を用い改善が得られることが多いですが、それでも頑固な鼻づまりに悩まされる方も少なくありません。また、継続的な治療のために定期的な通院が必要となり、その分コストもかかってしまいます。そこでお勧めしたいのが、外来での局所麻酔の手術です。

当院ではコプレーターというラジオ波凝固装置を用い、肥太した下鼻甲介をポリウムダウンさせる手術を行っています。鼻のレーザー手術と混同しやすいですが、使用する装置、粘膜を焼灼する部位や範囲など、厳密にはレーザー手術とは異なります。レーザー手術と比べ、焼灼する粘膜の体積も大きいため、圧制的に粘膜を収縮させる効果は高いです。広範囲に下鼻甲介をスリム化させるため、鼻づまりに対する効果は極めて高いと言えます。一方、鼻水でお悩みの方の場合は、コプレーターだけでは十分な効果を得られないケースも多いです。(鼻水は下鼻甲介以外の鼻内粘膜からも作られるため。)

個人差はありますが、治療効果は5年以上保てる方が多いです。10年経過しても下鼻甲介がスリムなままの方もいらっしゃいます。アレルギー反応が極めて強い方や、一般的に粘膜の再生能力が強いお子さんの場合は、もう少し短時間で下鼻甲介が再増殖することもあります。再発の手術により改善が図れます。なお、アレルギーの体質自体が改善するわけではないため、花粉症の予防は必要になる場合もあります。



肥下鼻甲介・手術前

肥下鼻甲介・手術後

外耳道炎

Tx) リンデロン点耳, 軟こう
キ/ロニ点耳・内服

悪性外耳道炎

高齢者, DM患者で多い。
緑膿菌 → 活性
Tx) ペトシリン (PIPC)

急性副鼻腔炎

頬骨痛, 頭痛, 歯痛を確認

好酸球性副鼻腔炎

鼻茸 (多数あることが多い) 粘稠度高く, やや黄色の鼻汁
↳ 嗅覚障害 篩骨洞優位
喘息の既往 70/HPF以上で難病申請
Tx) (難治) デュセクセト, スーカ

慢性副鼻腔炎

3か月以上続く鼻閉・後鼻漏・咳嗽

低用量マクロライドを3か月継続

改善なし → 菌性上顎洞炎, 真菌症の可能性も考慮

↓
CTで歯根部に Low density

アレルギー性真菌性 (AFRS)

Tx) ステロイド
著効

耳管開放症

やせ型で運動, 急激な体重減少・ダイエット による
自分の声・鼻息が強く聞こえる (自声強調)

対応) 患側臥位

スカフ・ネクタイなどで頸部圧迫

→ 血流量を促し
周囲の脂肪組織で耳管狭める

去痰薬	ムコダイン	(カルボシステイン)
	ムコソルバン	(アンブロキソール)
	ワリアナール	

耳痛 ... 胸鎖乳突筋の過緊張によることがある。

クバモックス	AMPC : クバアン酸	= 4 : 1	×イアクト	CDTR-PI
オーブ×=チン		2 : 1	70モックス	CFPN-PI

ステロイド治療 副作用チェック 胃潰瘍, 覚醒, 浮腫

抗ヒスタミン	H_1	: 抗アレルギー
	H_2	: ガスター, ファモチジン

唾液腺腫張
炎症 (細菌・ウイルス・唾石)
腫瘍
膠原病 (SS, サルコイドーシス, IgG4)

甲状腺 径 40mm 以上, サイログロブリン > 1000 で抽出

片頭痛関連めまい

Shellong Test

Active standing			
Recommendation			
Indication		Class	Level
血圧計を用いて臥位値でBPとHRを測定し、3分間の休息の間に定期的に測定することが、失神の早期評価の目的とする。		I	C
初期の低血圧値による短時間のBPの変動が疑われる場合には、非侵襲的なBPとHRの連続的な自動測定が好ましいかもしれない。		Ib	C
Diagnostic criteria	①収縮期BPが20mmHg以下、かつ拡張期BPが10mmHg以下に低下、or ②収縮期BPが90mmHg以下に低下、のいずれかあり、かつ自発的な症状が出現した場合にOHと確信できる。		
起立性低血圧による失神との区別診断	①収縮期BPが20mmHg以下、or ②拡張期BPが10mmHg以下に低下、or ③収縮期BPが90mmHg以下に低下、のいずれかあり、かつ（両側から）両手が一致する範囲でOHの可能性が高いと考える。	Ia	C
OH: Orthostatic hypotension	①収縮期BPが20mmHg以下、or ②拡張期BPが10mmHg以下に低下、or ③収縮期BPが90mmHg以下に低下、のいずれかあり、かつすべての両側でOHを呈していない場合もOHの可能性が高いと考える。	Ia	C
POTSの診断 POTS: Postural orthostatic tachycardia syndrome	①収縮期BPが20mmHg以下、or ②拡張期BPが10mmHg以下に低下、（両手による）両手が一致しない場合でも、OHの可能性が高いと考える。 ③立位時の心拍数増加率（心拍数/分）が30/分（10/分以下）（12歳以上）（12歳以下）と異なる。	Ib	C
	可能性が高いと考える。	Ia	C

漢方

五苓散：回転性めまい，メニエール病

苓桂朮甘湯：起立性めまい，BPPV

真武湯：浮動性めまい，冷え症